PROTOCOLLO 64

Correzione della deviazione in apertura

Ridurre la deviazione con esercizi guidati

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Deviazione persistente
- ✓ Click in apertura
- ✓ Asimmetria muscolare

Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Guida

Dito sul lato verso cui avviene la deviazione.



Apertura

Apri lentamente opponendoti alla deviazione.



Controllo

Usa lo specchio come feedback.



Riduzione della guida

Diminuisci gradualmente l'aiuto manuale.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10
Serie	3 al giorno
Criterio	traiettoria retta

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Guida leggera
- ✓ Velocità lenta
- ✓ Progressione nel controllo

Errori da evitare

- ! Spinta forte con il dito
- ! Ignorare il dolore
- ! Aperture massimali

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura guidata	Apertura con un dito che corregge la deviazione	10 ripetizioni, 3 volte al giorno

! **Nota clinica.** La deviazione funzionale risponde bene al controllo motorio con feedback.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.